

26. PRATICA : I POLMONI

DURATA : 05:35

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video si concentra sull'approccio biodinamico ai polmoni, evidenziando come il movimento di oscillazione dei polmoni e la ricerca del punto di fulcro embrionale siano essenziali per ripristinare la loro funzione primaria. I partecipanti impareranno a osservare la dinamica tra i polmoni, la pleura e il tessuto circostante, in particolare come le emozioni, come la tristezza, possano annidarsi lì e influenzare la respirazione. Vengono anche trattate tecniche volte a iniziare un dialogo tissutale e a liberare gli spazi pleurici ingombrati da essudati, sottolineando l'importanza della riorganizzazione strutturale ed emotiva dei polmoni per migliorare la salute respiratoria.

PRATICA DEI POLMONI

La **mano posteriore** è leggermente più bassa della **mano anteriore**, che è leggermente più alta. Ciò è dovuto al movimento di **oscillazione** dei polmoni sul loro asse. Questo movimento è essenziale per posizionarsi nel **campo embrionale** dei polmoni, dove si ricerca il **punto di fulcro embrionale**. Questo punto rappresenta un campo di aspirazione, permettendo di ripotenziare la funzione primaria dei polmoni, cioè essere pronti a **prendere il soffio della vita**.

Durante i nove mesi di sviluppo embrionale, i polmoni sono preparati a questo primo movimento. Producono **liquido amniotico**, una funzione cruciale poiché l'embrione ne ha bisogno per la sua sopravvivenza. Questo liquido deriva in parte dall'urina dei reni. Più tardi, verrà prodotta una **proteina specifica** chiamata **surfactante**, che permetterà l'apertura dei polmoni al momento della nascita.

Inizialmente, la pressione esercitata è delicata. Si tratta di ritrovare progressivamente uno spazio dove il polmone possa organizzarsi e ritrovare la sua libertà. Tra la **pleura viscerale** e la **pleura parietale**, esiste un incontro tra la trachea, il bronco e il tessuto bronchiale aereo, che contiene aria e un volume residuo, oltre a uno spazio liquido.

È importante notare che questo tessuto può ospitare emozioni, come una **tristezza** interiorizzata. Ad esempio, un bambino che piange nei suoi polmoni o che soffre di bronchiti può esprimere una tristezza che non sa verbalizzare. Lavorando delicatamente su questo tessuto, è possibile avviare un dialogo e uno scambio **ossidativo tissutale**.

Attraverso la **grande scissura posteriore**, si può accedere a spazi dove sono nascoste emozioni. È essenziale lasciare che il corpo lavori e concentrarsi sull'asse di riorganizzazione. I **recessi costopleuropolmonari** sono sacche di accumulo di essudati, dove si depositano i rifiuti dei polmoni. Queste zone, spesso meno mobili, necessitano di essere dinamizzate e liberate.

È anche cruciale liberare i polmoni rispetto ai loro punti di attacco, in particolare i **legamenti sospensori della cupola pleurica**. I recessi, come i **recessi costodiaframmatici** e il **recesso frenomediastinico**, giocano un ruolo importante nella libertà del mediastino e del cuore.

La produzione di liquido amniotico inizia dalla **quinta settimana** di gravidanza e si sviluppa fino alla **38a settimana**, con la comparsa del surfactante intorno alla **25a settimana**. Le patologie polmonari, come la bronchite o la bronchiolite, possono essere manifestazioni che cercano di risolvere problemi non espressi durante lo stadio embrionale, manifestandosi sotto forma di **liquido**. Si può dire che si "piange nei polmoni".

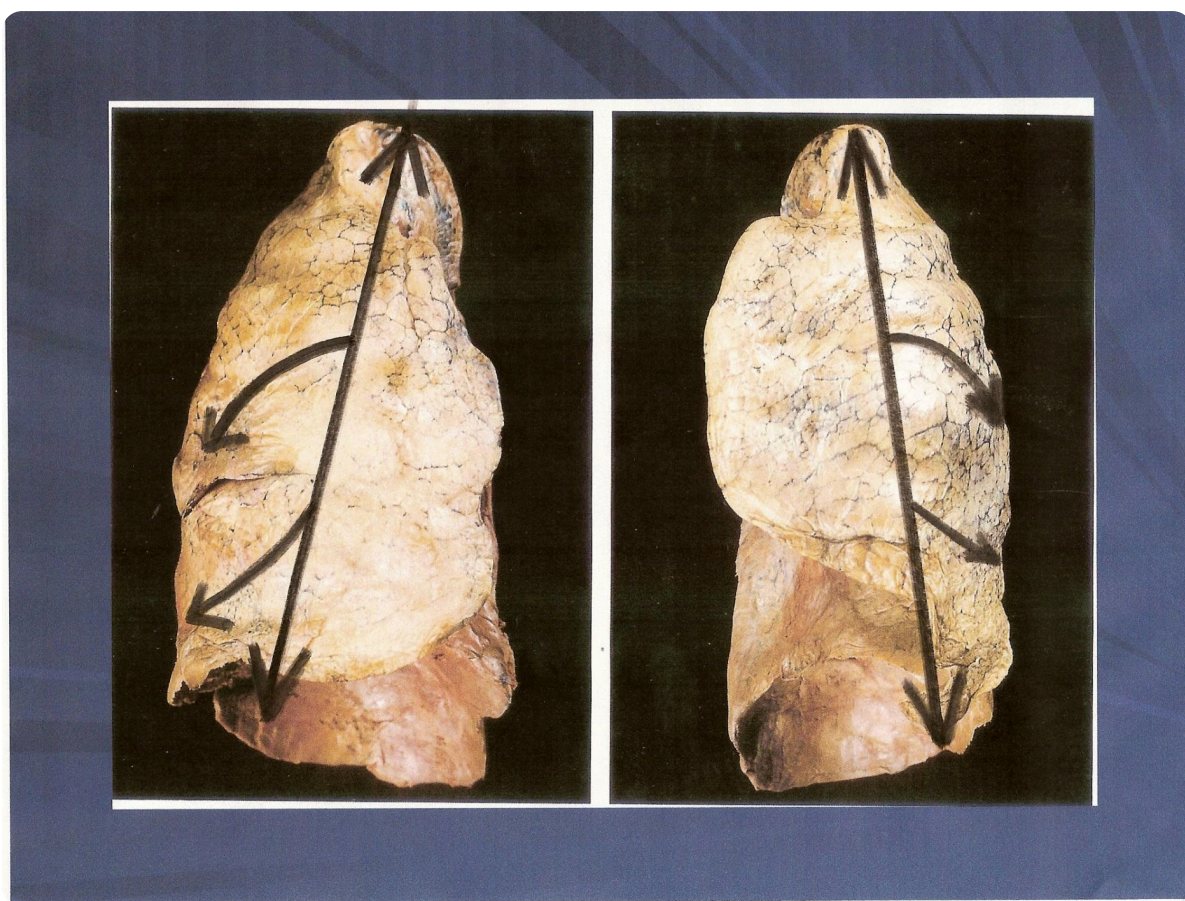


FIG. — Lobo superiore obliquo

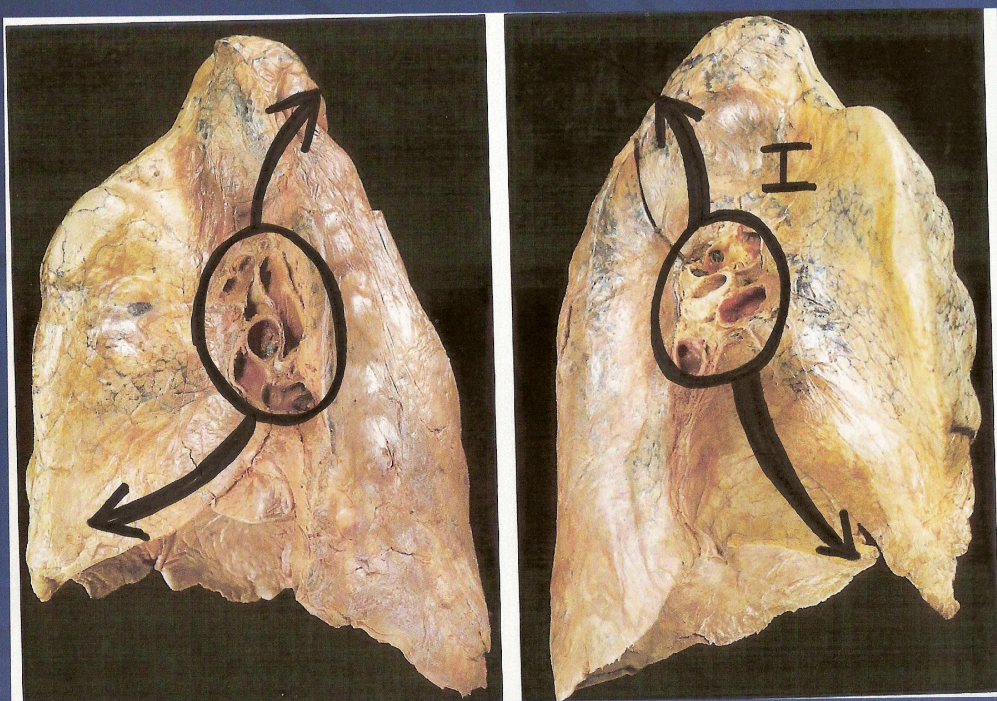


FIG. — *Malattia polmonare cistica*